

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Carmen Rosa Velásquez Ortiz

DOCUMENTO

CC 20123456

FECHA NACIMIENTO

22/07/1952

EDAD

74 años, 5 meses

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

Primaria Incompleta

LATERALIDAD

Diestra

FECHA DE EVALUACIÓN

11/01/2027

ORDEN N°

—

PROTOCOLO APLICADO

bateria_emergencia_am

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Carmen Rosa Velásquez Ortiz	Lateralidad:	Diestra
Documento:	CC 20123456	Ocupación:	Pensionada (ex-docente)
Fecha de nacimiento:	22/07/1952	Ciudad:	Cali
Edad:	74 años, 5 meses	Acompañante:	Hija María Velásquez
Sexo:	Femenino	Remite:	Hija (familia)
Escolaridad:	Primaria Incompleta	EPS / Asegurador:	Nueva EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Hija refiere cuadro de 6 meses: tristeza persistente, aislamiento, pérdida de interés, llanto frecuente, y EXPRESA IDEA DE QUERER 'DESCANSAR'. Dormitorio desordenado con medicamentos acumulados.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: bateria_emergencia_am

Prueba	Dominio	Dur.
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	Socioemocional - Depresión	—
Span Retención Dígitos Directo	Memoria de Trabajo	—
Span Retención Dígitos Inverso	Memoria de Trabajo	—
TMT A	Atención	—
Grober RL Ensayo 1 (libre)	General	—
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)	General	—
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)	General	—
Fluidez Verbal Animales	Lenguaje - Fluidez	—
Escala de Lawton y Brody (IADL)	General	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Psiquiátricos

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Traumáticos

Niega TEC previo.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Perfil neuropsicológico global: $Z = -1.4\sigma$ sobre 4 dominios evaluados.

Hallazgos clave

- General severamente descendido ($Z = -2.2\sigma$)

Implicación

Se recomienda intervención prioritaria en el dominio con mayor descenso, con seguimiento cercano de la evolución.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica. Paciente colaborador.

Atención y concentración

Atención fluctuante, hipoprosexia, se desconecta durante la entrevista. Refiere dificultad para concentrarse ('la cabeza no me da').

Memoria

Quejas subjetivas de memoria. Olvida citas y nombres. Familiares confirman deterioro en los últimos 6 meses. Grober Buschke con deterioro en recuerdo libre (2/16) con mejoría en reconocimiento (8/16) — perfil subcortical-frontal.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Lenguaje hipofluente, latencias aumentadas, voz (baja). Responde con monosílabos. Denominación conservada (animales: 6).

Funciones ejecutivas

Rigidez cognitiva. Dificultad para alternar categorías en fluencia. Bradipsiquia marcada en TMT-A (245 segundos, escalar 6).

Emociones y comportamiento

ACTITUD DEPRESIVA PROFUNDA. Llanto durante la entrevista. Expresa: 'ya no quiero seguir así'. Ideación suicida ACTIVA con plan pasivo (acumular medicación). C-SSRS: IDEACIÓN + PLAN + INTENCIÓN = RIESGO ALTO.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo: F32.1 - Episodio depresivo moderado + RIESGO SUICIDA ALTO

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente

Escala de Depres

13

Deficit Extremo

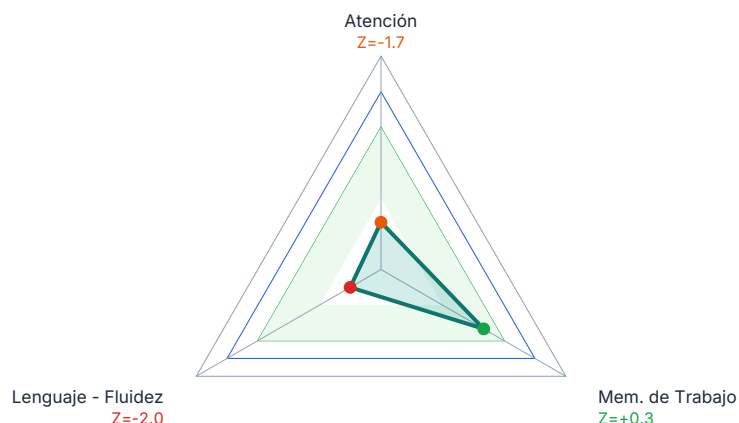
Escala de Lawton

4

Deficit Extremo

Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a +1 σ).

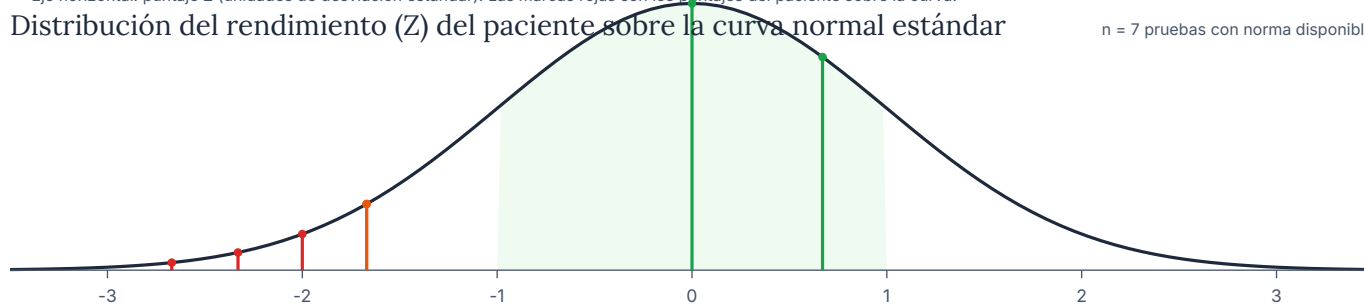


Curva normal con puntajes Z del paciente

Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.

Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 7 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

Perfil Z por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage							-5.80
Span Retención Dígitos Directo							+0.67
Span Retención Dígitos Inverso							+0.00
TMT A							-1.67
Grober RL Ensayo 1 (libre)							-2.67
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)							-1.67
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)							-2.33
Fluidez Verbal Animales							-2.00
Escala de Lawton y Brody (IADL)							-6.40

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z < -1 sugiere debilidad. Z > +1 sugiere fortaleza relativa.

Semáforo de dominios cognitivos

DOMINIO	Z ⁻	BANDA
● General	-2.22σ	severo
● Lenguaje - Fluidez	-2.00σ	severo
● Atención	-1.67σ	moderado
● Memoria de Trabajo	+0.34σ	promedio

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	13	13	-5.80	Deficit Extremo
Span Retención Dígitos Directo	5	12	+0.67	Promedio
Span Retención Dígitos Inverso	3	10	+0.00	Promedio
TMT A	247	5	-1.67	Límitrofe
Grober RL Ensayo 1 (libre)	3	2	-2.67	Bajo
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)	3	5	-1.67	Límitrofe
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)	6	3	-2.33	Bajo
Fluidez Verbal Animales	7	4	-2.00	Bajo
Escala de Lawton y Brody (IADL)	4	4	-6.40	Deficit Extremo

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: general (severamente disminuido, $Z=-2.2$); lenguaje - fluidez (severamente disminuido, $Z=-2.0$); atención (moderadamente disminuido, $Z=-1.7$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Grober RL Ensayo 1 (libre) ($Z=-2.67$, bajo); Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) ($Z=-2.33$, bajo); Fluidez Verbal Animales ($Z=-2.00$, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Grober RL Ensayo 1 (libre) — bajo ($Z=-2.67$)
- Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) — bajo ($Z=-2.33$)
- Fluidez Verbal Animales — bajo ($Z=-2.00$)
- Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3) — límiterofe ($Z=-1.67$)
- TMT A — límiterofe ($Z=-1.67$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Carmen. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Span Retención Dígitos Inverso, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En TMT A, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En Grober RL Ensayo 1 (libre), encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte. En Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3), tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.

Implicaciones para la vida diaria

Además de los puntajes, esto es lo que podría notarse en la vida cotidiana:

General · severo

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Lenguaje - Fluidez · severo

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Atención · moderado

- Mantener el foco en una conversación larga (especialmente en reuniones o clases).
- Seguir instrucciones de varios pasos sin perder algún detalle.
- Filtrar estímulos distractores en lugares ruidosos o con mucha gente.

Apoyos sugeridos: Dividir el trabajo en bloques de 20-25 minutos con pausas activas. · Usar temporizadores visuales (Time Timer) y listas de verificación.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Span Retención Dígitos Inverso, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En TMT A, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Grober RL Ensayo 1 (libre), encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3), tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3), encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Fluidez Verbal Animales, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.

¿Qué recomendamos?

Recomendación: URGENTE: Activar protocolo de seguridad. No dejar sola a la paciente. Contactar a hija María (acudiente) para acompañamiento 24/7. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Sobre la consulta médica: si tu psicólogo/a lo sugiere, agenda una cita con psiquiatría para discutir opciones de tratamiento. Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta. Sobre la consulta médica: si tu psicólogo/a lo sugiere, agenda una cita con psiquiatría para discutir opciones de tratamiento.

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Qué significa un puntaje 'bajo' o 'muy bajo'?

Significa que, comparado con personas de la misma edad y nivel educativo, esa función específica rindió por debajo de lo esperado. NO es un diagnóstico en sí mismo. Es una señal para profundizar, entrenar y apoyar esa área. Tu psicólogo/a te explicará si requiere intervención profesional adicional.

¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F32

Impresión diagnóstica: F32.1 - Episodio depresivo moderado + RIESGO SUICIDA ALTO

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

Familiar

- Retirar medios letales del domicilio (medicamentos, armas, cuerdas). La hija debe administrar la medicación.
- Plan de seguridad escrito: contactos de emergencia (línea 106, hija, vecina), lugares seguros, señales de alerta.
- Coordinación con médico de familia para evaluación de comorbilidades (tiroides, B12, anemia).

Terapéutica

- URGENTE: Activar protocolo de seguridad. No dejar sola a la paciente. Contactar a hija María (acudiente) para acompañamiento 24/7.
- URGENTE: Remisión a PSIQUIATRÍA en las próximas 24-48 horas para evaluación de tratamiento farmacológico (ISRS) y nivel de cuidado.
- Iniciar psicoterapia breve (8-12 sesiones) orientada a activación conductual + psicoeducación familiar.

Recomendaciones del cuadro clínico

Banco de recomendaciones clínicas sugeridas para el cuadro identificado. El clínico debe seleccionar las aplicables antes de emitir el informe definitivo.

Demencia tipo Alzheimer (F000 / F001 / F002) · Adulto Mayor (50+ años)

- Seguimiento neurológico/geriátrico para manejo farmacológico (anticolinesterásicos, memantina).
- Estimulación cognitiva adaptada al estadio — no sobrecargar.
- Rutinas estables, ambiente predecible, etiquetado de espacios.
- Cuidador entrenado: psicoeducación sobre progresión y técnicas de manejo conductual.
- Control de comorbilidades médicas — especialmente delirium intercurrente.
- Revisión de polifarmacia — evitar anticolinérgicos y benzodiacepinas.
- Adaptación del hogar: seguridad, pasamanos, iluminación, retiro de alfombras.
- Planeación anticipada: voluntad anticipada, apoyo legal, decisiones financieras.